

«Гіпертрофічна кардіоміопатія»

1. Завдання, що виконуються здобувачем освіти на станції:

- Зняти електрокардіограму.
- Описати ЕКГ.
- Оцінити ЕХОКС.
- Встановити попередній діагноз.
- Визначити тактику ведення та лікування.
- Означити рекомендації щодо профілактики та пропаганди здорового способу життя.

2. Клінічні кейси (сценарії, задачі), які відпрацьовуються на станції з пакетами додаткових матеріалів:

- Сценарій «Діагностика та подальша тактика ведення і лікування хворого з діагнозом гіпертрофічна кардіоміопатія»:

Ви - лікар терапевтичного відділення. До Вас звернулася жінка, 56 років, перукар.

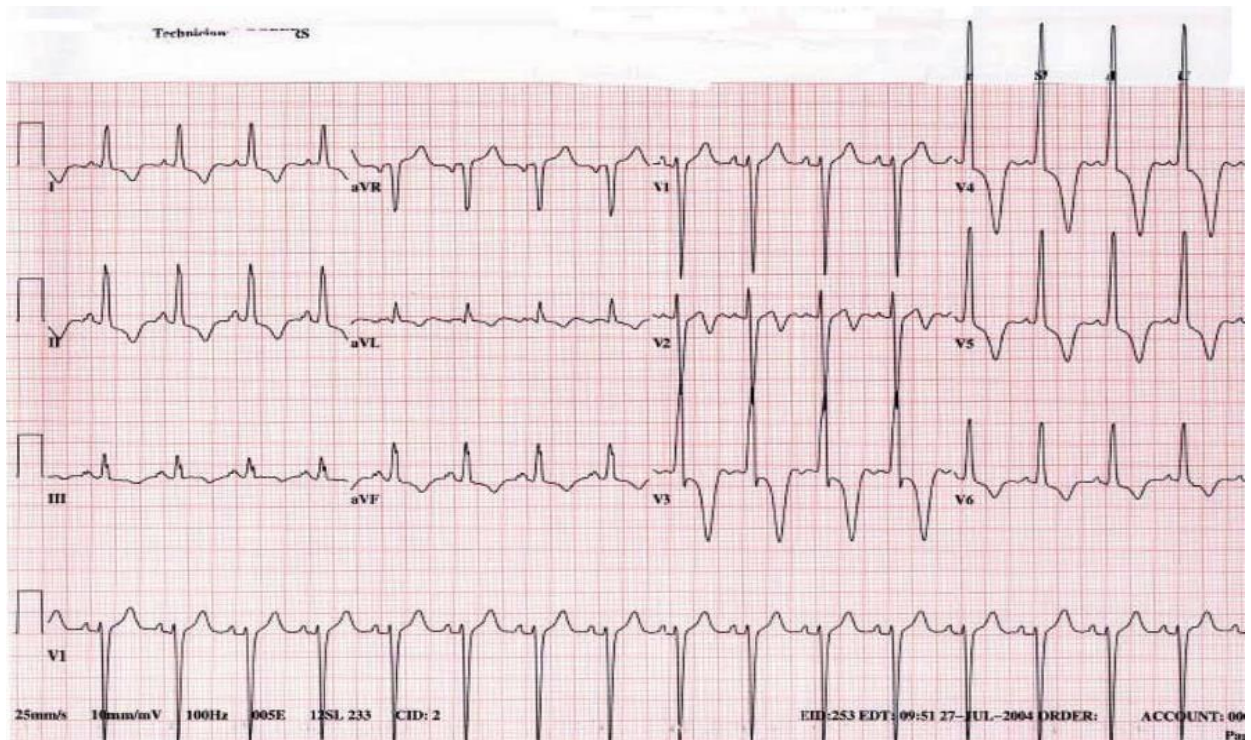
Скарги на стискаючий біль за грудиною, що виникає при ходьбі, інспіраторну задишку при незначному фізичному навантаженні, серцебиття, періодично перебої в серцевій діяльності.

Анамнез захворювання: 5 років тому вперше в житті після стресу втратила свідомість. Після чого почала помічати, що після стресу з'являється запаморочення, іноді біль в серці. Не лікувалась. Останні 3 роки крім болю в серці, турбує задишка, серцебиття. Останній місяць посилився біль, задишка.

Анамнез життя: туберкульоз, вірусні гепатити, цукровий діабет заперечує. Протягом життя хворіла ГРВІ, бронхітом. Операції, травми протягом життя – заперечує. Алергійні реакції, непереносимість ліків – заперечує. Спадковість (серцево-судинні захворювання) - брат помер у молодому віці, 34, грав з друзями у волейбол, раптово впав, помер (від гострої серцевої недостатності) до приїзду швидкої.

Об'єктивне обстеження: стан середньої тяжкості. Підшкірно-жирова клітковина розвинута надмірно. Шкіра блідо-рожева, чиста, суха. Пастозність стоп і гомілок. У легенях – везикулярне дихання. ЧСС=Пульс=82 за хв., АТ на обох руках 130/90 мм рт.ст. Живіт м'який безболісний. Печінка не виступає з під краю реберної дуги. Випорожнення та сечовипускання без особливостей.

- Додаток 1 ЕКГ



• **Додаток 2 ЕХОКГ**

ТРАНСТОРАКАЛЬНЕ УЛЬТРАЗВУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СЕРЦЯ З КОЛЬОРОВОЮ ДОПЛЕРОГРАФІЄЮ

Аорта:

Аорта (корінь) **3,2 см** (2,2-3,6 см).

Стінки аорти не змінені.

Ампл. розкр. стулокаорти **2,0 см** (1,5-2,2 см).

Стулки аортального клапану фіброз.

Стеноз Ао клапану відсутній.

Ліве передсердя:

Ліве передсердя (передньо-задній розмір) **4,2** (4 см).

Стулки мітрального клапану не змінені.

Розкриття мітрального клапану **2,3 см** (1,9 - 2,8 см).

Стеноз мітрального клапану відсутній.

Лівий шлуночок:

Кінцево-діастолічний діаметр ЛШ (КДР) **4,8 см** (3,5- 5,6 см).

Кінцево-систолічний діаметр ЛШ (КСР) **3,2 см** (2,3 -4,0 см).

Кінцево-діастолічний об'єм ЛШ (КДО) **107 мл** (70-160 мл).

Кінцево-систолічний об'єм ЛШ (КСО) **40 мл** (20-70 мл).

Товщина стінки перегородкового, верхівкового сегментів лівого шлуночка -20 мм, гіпокінезія перегородкового, верхівково сегментів.

Асиметрична гіпертрофія лівого шлуночка з помірною обструкцією виносящего тракту (р 32 мм рт.ст.).

Маса міокарду **97 г** (95 г (ж) 135 г (ч)).

Фракція викиду ЛШ (Teicholz) **62%** (55-65%).

Фракція скорочення **32%** (28 - 43%).

Задня стінка діаст. **1,0 см** (0,6-1,1 см).

Правий шлуночок та праве передсердя:

Правий шлуночок **2,8 см** (3,0 см).

Товщин астинки ПШ **0,5 см.**
 Праве передсердя (медіально-латеральнийрозмір) **3,8 см** (2,0-3,8 см).
 Стулки 3-стулков. клапану – **норма.**
 Стовбур легеневої артерії**3,0 см**(2,0-3,3 см),
 Реакція нижньої порожистої вени на фази дихання нормальна.

Висновок: асиметрична гіпертрофія лівого шлуночка з помірною обструкцією виносного тракту (32 мм рт.ст.), гіпокінезія перегородкового, верхівкового сегментів. Систолічна дисфункція задовільна, діастолічна дисфункція по 1 типу. Незначна дилатація лівого передсердя. Фіброз аортального клапана 1-2 ст. Перікард без особливостей. (ФВ-62%).

3. Інформація для студента – алгоритм роботи на станції.

Ви зібрали скарги, анамнез захворювання та життя, провели об'єктивне обстеження:

Алгоритм дій здобувача.

	<i>Дії здобувача освіти</i>
1.ІНШЕ (В Т.Ч. ЛЕГАЛЬНІ ТА ЕТИЧНІ АСПЕКТИ):	
	Інформовану згоду отримано;
	Обробити руки на гігієнічному рівні
2.ВИКОНАННЯ НАВИЧКИ «РЕЄСТРАЦІЯ ЕКГ У 12 СТАНДАРТНИХ ВІДВЕДЕННЯХ»	
	Нанести гель або воду на місце постановки електродів
	Коректне накладання 4 пластинчатих (стандартних) електродів: - червоний - права верхня кінцівка - жовтий - ліва верхня кінцівка - зелений - ліва нижня кінцівка - чорний - права нижня кінцівка
	Коректне накладання грудних електродів: 1-й – 4 м/р біля краю грудини справа; 2-й - 4 м/р біля краю грудини зліва; 4-й – 5 м/р по середньо-ключичній лінії зліва; 3-й – по середині між 2-м та 4-м електродами; 5-й – 5 м/ по передній пахвинній лінії;

	6-й - 5 м/ по середній пахвинній лінії.
	Реєстрація ЕКГ (натиснути «Пуск»)
	Зняття стандартних і грудних електродів з пацієнта
	Самопочуття пацієнта задовільне
3. ДІАГНОСТИКА:	
<i>Описати ЕКГ</i> (Додаток 1)	Ритм синусовий. Правильний. ЧСС – 100 за хв., електрична вісь 50°. Інверсія зубців Т у відведеннях II, III, aVF, V2-V6, депресія сегменту ST в V3 - V6. Високоамплітудні QRS у грудних відведеннях Критерії Соколова-Лайона > 35 мм, що свідчить про гіпертрофію міокарда ЛШ.
<i>Оцінити ЕХОКС</i> (Додаток 2)	асиметрична гіпертрофія лівого шлуночка (більше 15 мм) з помірною обструкцією виносного тракту, гіпокінезія перегородкового, верхівково-бокового сегментів, діастолічна дисфункція свідчать про можливу наявність у хворого гіпертрофічної кардіоміопатії
<i>Встановити попередній діагноз:</i>	Гіпертрофічна кардіоміопатія
4.ВИЗНАЧЕННЯ ТАКТИКИ ВЕДЕННЯ ТА ЛІКУВАННЯ	
<i>Призначено наступні ліки:</i>	Госпіталізація для подальшого обстеження та підбору оптимальної терапії. β-блокатори анаприлин Блокаторы кальциевых каналов - верапамил Калійзберігаючі діуретики (антагоністи альдостерону) - спіронолактон.
5. Профілактика та пропаганда здорового способу життя:	

	ведення здорового способу життя скринінг членів сім'ї профілактика бапендокардиту
--	--